猎丰医院等级评审管理系统

——对标 2025 新标准：从“突击迎检”转向“常态化智慧监管”，助力医院高分达标

【产品背景】

随着《三级医院评审标准（2025 年版）》的正式发布与实施，国家医院等级评审已彻底告别“突击迎检”与“现场检查”的传统模式，全面迈入以“日常监测、客观指标、定量数据”为核心的数字化评审新时代。

新标准涉及 97 节、232 条核心指标，涵盖了医疗质量安全、运行效率、持续改进等方面，对数据的真实性、逻辑性与同质化提出了前所未有的要求。面对这一变革，医院迫切需要构建一套智能化的全院级评审管理平台，打通 HIS、病案、电子病历等数据孤岛，通过实时监控与 AI 预警，将评审要求融入日常诊疗全流程，实现从“事后补救”到“事前管理”的根本性转变。

【行业现状】

在应对三级医院等级评审时，医疗机构普遍面临以下痛点：

1. **数据采集压力巨大：** 232 条指标涉及全院各职能、临床科室，依靠人工统计不仅效率低，且极易出错。
2. **数据质量难以保障：** 原始数据来源复杂，缺乏有效的逻辑校验，常导致上报数据与国家/省级平台抓取数据不一致，影响评审得分。
3. **管理滞后无预警：** 传统模式下，医院往往在评审临近时才发现指标不达标，缺乏日常监测和红灯预警机制，失去了持续改进的机会。
4. **PDCA 闭环难落实：** 发现问题后，缺乏信息化的流程追踪工具，改进措施往往停留在纸面上，无法形成真正的闭环。

【产品概述】

猎丰医院等级评审管理系统是专为新时代“数据评审”量身打造的智慧管理方案。系统深度集成《三级医院评审标准（2025 年版）》，通过构建全院级数据中心（CDR），实现对评审指标的自动抽取、精准计算、动态监控与辅助决策。

平台不仅是一个数据上报工具，更是一个管理工具。它通过 AI 智能分析帮助医院识别质量缺陷，引导科室开展 PDCA 循环，确保医院在日常监测中始终保持高水准，真正实现评审工作的“常态化、精细化、科学化”。

【产品特点】

1. 深度内置 2025 新标准，实现“精准对标”

- **指标库全覆盖：** 完整集成 2025 版评审标准及各省实施细则，包含前置要求（29 条）及日常监测指标。
- **逻辑自动转换：** 将复杂的文本标准转化为计算机可执行的计算公式，确保院内自评与国家评审逻辑完全同质。

2. 多源数据无缝集成，打造“客观评审”底座

- **全量数据接入：** 自动对接 HIS、EMR、LIS、PACS、HQMS、HRP 等系统，实现评审指标的“一键生成、自动汇总”。
- **数据质量校验：** 内置强大的校验引擎，可自动识别数据逻辑冲突（如总数与分类不符），确保数据的真实性与准确性。

3. AI 动态监测与风险预警

- **达标率实时看板：** 院领导和管理部门可实时查看全院评审达标进度及各维度得分情况。
- **指标红灯预警：** 针对未达标指标、滑坡指标，系统通过 AI 算法自动触发预警，并精准推送到指定部门或个人，提醒及时介入管理。

4. PDCA 持续改进在线闭环

- **管理痕迹化：** 针对不达标指标，系统支持在线开启 PDCA 改进项目，记录背景、目标、措施及成效。
- **持续改进证据链：** 自动收集改进过程中的支撑文档、截图及改进后的数据变化，为评审提供详实的佐证资料。

5. 智能化自评报告生成

- **一键导出：** 系统可根据实时监测数据，按照评审要求的格式，一键生成医院年度自评报告。
- **智能对比分析：** 自动比对本院数据与行业平均值、基准值，辅助管理层精准定位弱项。

【参考标准】

本系统的构建严格遵循以下权威标准：

- **《三级医院评审标准（2025 年版）》**
- **《三级医院评审标准（2025 年版）》政策解读**
- 《国家公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》
- 《医疗质量管理办法》

- 《医疗质量安全核心制度要点》
- 《医疗质量安全核心制度落实情况监测指标(2025 年版)》
- 《三级综合医院医疗服务能力指南（2016 年版）》
- 《国家三级公立医院绩效监测操作手册（2025 版）》
- 《全国医院信息化建设标准与规范》
- 《计算机软件需求说明书编制指南 / GB9385-88》
- 《计算机软件开发规范 / GB8566-88》
- 《信息系统安全等级保护定级指南（GB/T 22240—2008）》
- 《中华人民共和国产计算机信息系统安全保护条例》
- 《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》

【预期目标】

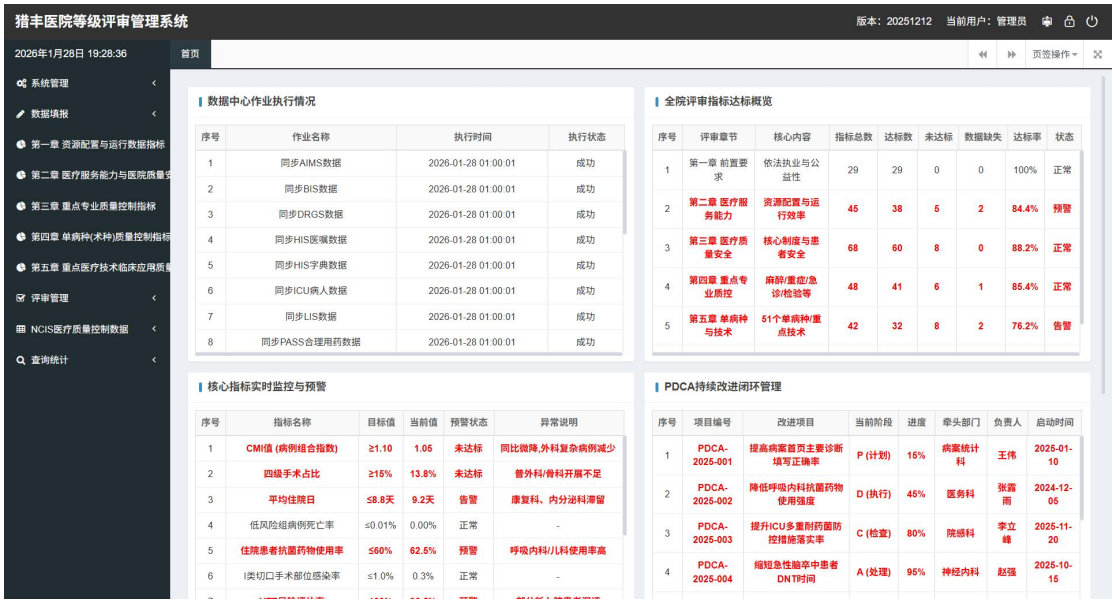
1. **减轻管理负担：** 实现评审数据收集的自动化，减少行政与医护人员 80%以上的数据收集和报表填报工作。
2. **确保评审高分：** 通过前置化的日常监测与改进，确保核心指标及前置要求 100%达标，规避评审风险。
3. **驱动内涵式增长：** 以评审为抓手，真实提升医院的医疗质量管理水平与运行效率。
4. **提升数据透明度：** 消除数据孤岛，为医院管理层提供“看得见、管得准”的决策依据。

【项目前景】

随着国家卫健委明确取消现场检查，以“数据说话”的评审模式已成为不可逆转的趋势。本平台紧跟政策前沿，不仅能帮助医院在新一轮等级评审中顺利过关，更能作为智慧医院运营管理的“大脑”，为医院的长远健康发展提供持续的数字化动力。

【产品展示】

首页数据大屏：包含全院评审指标达标概览、核心指标实时监控与预警、PDCA 持续改进闭环管理等实时数据展示。



资源配置与运行数据指标：包含三级医院评审标准（2025 年版）第一章要求的资源配置与运行数据指标及明细数据查询，查询类型包括年度、季度、月度等。



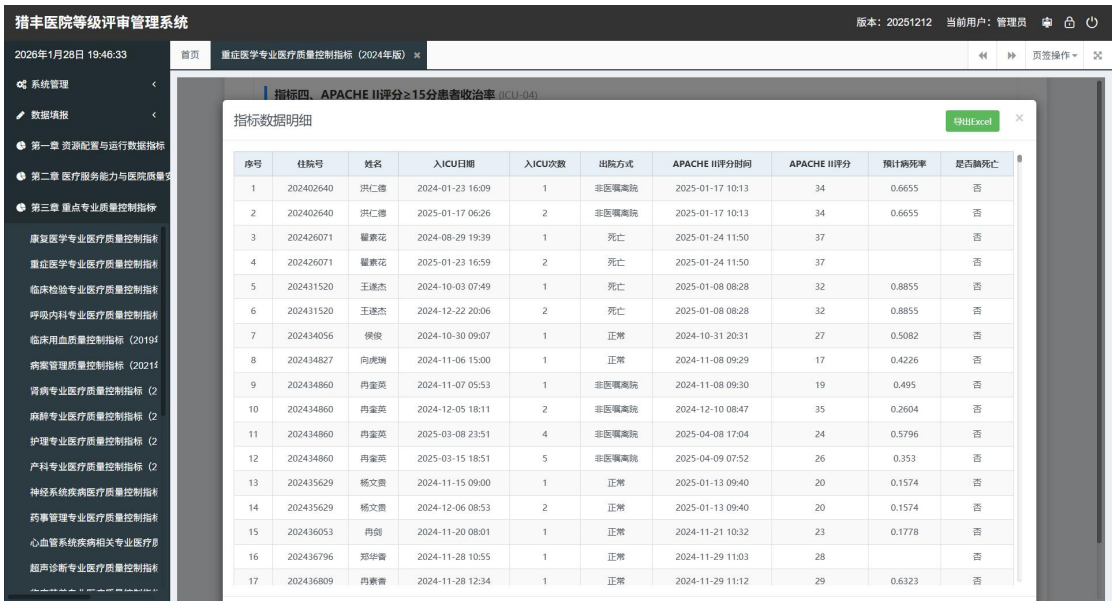
医疗服务能力与医院质量安全指标：包含三级医院评审标准（2025 年版）第二章要求的医疗服务能力与医院质量安全指标及明细数据查询，查询类型包括年度、季度、月度等。



重点专业质量控制指标：包含三级医院评审标准（2025 年版）第三章要求的重点专业质量控制指标及明细数据查询，查询类型包括年度、季度、月度等。







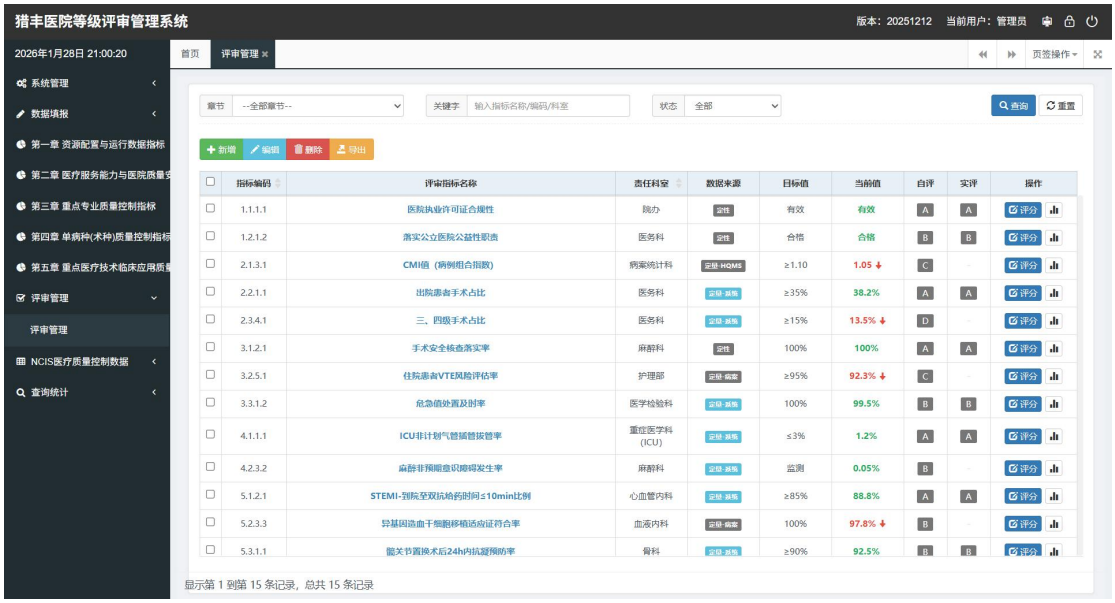
单病种（术种）质量控制指标：包含三级医院评审标准（2025 年版）第四章要求的所有单病种（术种）质量控制指标及明细数据查询，查询类型包括年度、季度、月度等。



重点医疗技术临床应用质量控制指标：包含三级医院评审标准（2025 年版）第五章要求的重点医疗技术临床应用质量控制指标及明细数据查询，查询类型包括年度、季度、月度等。



评审管理：包含指标详情、自评、实评、佐证材料管理等功能。


猎丰医院等级评审管理系统
版本：20251212 当前用户：管理员
2026年1月28日 21:00:20
首页
评审管理
页签操作
系统管理
数据填报
第一章 资源配置与运行数据指标
第二章 医疗服务能力与医院质量
第三章 重点专业质量控制指标
第四章 单病种(术种)质量控制指标
第五章 重点医疗技术临床应用质
评审管理
评审管理
NCIS医疗质量控制数据
查询统计
章节
--全部章节--
关键字
输入指标名称/编码/科室
状态
全部
查询
重置
新增
编辑
删除
导出
指标编码
评审指标名称
责任科室
数据来源
目标值
当前值
自评
实评
操作
1.1.1.1 医院执业许可证合规性 院办 定性 有效 有效 A A 评分
1.2.1.2 落实公立医院公益性职责 医务科 定性 合格 合格 B B 评分
2.1.3.1 CMI值（病例组合指数） 病案统计科 定量 HQMS ≥1.10 1.05 C 评分
2.2.1.1 出院患者手术占比 医务科 定量 基层 ≥35% 38.2% A A 评分
2.3.4.1 三、四级手术占比 医务科 定量 基层 ≥15% 13.5% D 评分
3.1.2.1 手术安全核查落实率 麻醉科 定性 100% 100% A A 评分
3.2.5.1 住院患者VTE风险评估率 护理部 定量 病案 ≥95% 92.3% C 评分
3.3.1.2 危急值处置及时率 医学检验科 定量 基层 100% 99.5% B B 评分
4.1.1.1 ICU非计划气管插管拔管率 重症医学科(ICU) 定量 基层 ≤3% 1.2% A A 评分
4.2.3.2 麻醉非预期意识障碍发生率 麻醉科 定量 基层 监测 0.05% B 评分
5.1.2.1 STEMI-到院至双抗给药时间≤10min比例 心血管内科 定量 基层 ≥85% 88.8% A A 评分
5.2.3.3 异基因造血干细胞移植适应证符合率 血液内科 定量 病案 100% 97.8% B 评分
5.3.1.1 髋关节置换术后24h内抗凝预防率 骨科 定量 基层 ≥90% 92.5% B B 评分
显示第 1 到第 15 条记录，总共 15 条记录